Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 7 pages numérotées de 1 à 7 et comporte 1 QROC et 1 commentaire de texte.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot de votre RM :

BONJOUR LES SHSTARS

Déjà, un grand **bravo** d'avoir fait ce commentaire et d'ouvrir cette correction. C'est pas la partie la plus fun, mais comprendre les **attendus** vous sera utile ++ le jour J *(et oui la SHS n'est pas si mystérieuse que ça)*. En tout cas, j'espère que vous vous êtes accordés une **pause** bien méritée après ce tuto, que vous avez parlé à votre famille, à vos potes et que vous vous êtes un peu sortis la tête des cours. Petite anecdote, j'étais venu à l'anniv de ma pote le soir du tuto 3, 2 semaines avant les exams, et ça m'avait fait trop du bien de revoir tous mes potes avant d'entamer la période de révision. Tout ça pour dire que c'est ok de **s'accorder des pauses** quand on a besoin et de **PAS CULPABILISER** de le faire.

Bref pour en revenir à mon ptit tuto, j'espère que vous avez **kiffé le sujet** ! Je sais qu'il était pas simple et qu'il abordait des cours que vous veniez à peine de voir, mais c'est toujours utile de se confronter à des **défis** auxquels on n'est pas forcément **prêt**, notamment pour la gestion du **stress** et pour apprendre à se faire **confiance**. Encore une fois, ne vous focalisez pas sur les points que vous n'avez pas eu, mais essayez de comprendre les bouts de **raisonnement** qu'il vous manque. Ça arrive souvent de connaitre son cours mais sur le moment, de ne pas penser à mentionner des parties parce qu'on est dans le **rush** (3 pages en 1h30 la dinguerie quand même). C'est en relisant bien cette correction et en **comparant** avec ce que vous avez fait que vous intègrerez la logique du commentaire. Je vous laisse donc avec les pages qui suivent, savourez-les bien *(kiluidiiiitt)* !

Benjamin votre **RM** qui **E**tonnament s'appelle **B**enjamin

QROC

Quelles sont les particularités respectives du don d'organes entre vivants et post-mortem ?(10 lignes)

Correction de la QROC

Le don d'organes entre vivants et post-mortem possède un enjeu bioéthique qui se réalise dans le respect de deux principes fondamentaux : la solidarité interhumaine et le respect de la dignité humaine. Pour le don entre vivants, cela signifie le respect de l'autonomie du donneur et du receveur, en vérifiant l'absence de contre-indication, en recueillant le consentement explicite (le «opt-in») et en expliquant les risques. Le don post-mortem repose quant à lui sur la reconnaissance de la mort et le respect du corps mort, de la volonté du défunt avec un consentement présumé (le «opt-out») et l'accompagnement des proches.

Commentaire de texte

L'influence de l'environnement sur l'état de santé est connue depuis la médecine d'Hippocrate . Lorsqu'on découvrit que les maladies infectieuses étaient dues à des agents pathogènes provenant du milieu, on se mit à traiter l'eau, à conserver les aliments au froid, à éliminer les ordures. Les maladies infectieuses diminuèrent énormément dans les pays développés et les maladies cardio-vasculaires et les cancers devinrent les causes majeures de mortalité. On s'est ensuite intéressé aux styles de vie prédisposant à développer ces maladies chroniques et on a presque oublié, dans les pays industrialisés, le rôle que l'environnement distal et proximal pouvait jouer sur la santé. La santé des populations est affectée en effet par divers facteurs environnementaux généralement peu contrôlables au niveau individuel et dépendants au moins en partie d'instances collectives de niveau local, national mais aussi international . [...]

Prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement afin de mieux les maîtriser dans une optique de développement durable (élaboration de « normes d'exposition », application concrète du « principe de précaution ») est le prochain défi de l'écosanté, nouveau champ de recherches et d'applications au niveau international. Parmi les huit grands objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU (OMS, 2012b), sept relèvent directement de considérations environnementales et sanitaires [...].

La plupart des maladies sont plurifactorielles [...], et il est donc quasi impossible de retrouver le facteur déclenchant au niveau individuel [...]. Les risques environnementaux font l'objet d'une prise de conscience de la part de l'opinion, des responsables politiques, des industriels et des scientifiques. [...]. L'élaboration d'un véritable projet de santé environnementale exigera que tous les spécialistes de la santé et de l'environnement travaillent ensemble.

Marilou Bruchon-Schweitzer, Émilie Boujut (2021). « Les facteurs environnementaux et sociaux de la santé », *Psychologie de la santé : Concepts, méthodes et modèles (p. 83-193)*, Dunod, pp. 89-92.

Consigne : En vous appuyant sur vos connaissances et sur le texte, vous expliquerez sur quels fondements repose la conception actuelle de la relation entre santé et environnement. Vous expliquerez comment s'opère aujourd'hui la gestion des risques sanitaires environnementaux.

Propos introductif

Le texte proposé fait référence au CM5 sur « La santé et l'environnement ». L'analyse linéaire sera donc appuyée des définitions qui occupent une place centrale dans ce cours : la santé environnemmentale, les facteurs environnementaux... Le cours suit un ordre similaire au texte : d'abord, une analyse historique de la relation entre santé et environnement, puis une évaluation de la gestion actuelle des risques sanitaires environnementaux. Il faudra veiller à ne pas entrer dans le hors-sujet en développant des éléments du cours qui n'apparaissent pas ici, comme la notion d'exposome. Certains passages du texte vont nécessiter une clarification par des éléments du cours, comme le passage de l'approche de la contamination à l'approche de la configuration. Cela demande un travail d'analyse fondé sur la définition des concepts-clés et l'explicitation des transitions entre les différentes approches de la relation santé-environnement. Il reste ensuite à montrer la détérioration des conditions environnementales, qui explique le besoin d'une meilleure compréhension de la santé environnementale, et à définir les acteurs de ces enjeux mondiaux pour introduire la dimension politique et sociale de ces préoccupations.

Correction du commentaire

Ce texte est un extrait de chapitre intitulé « Les facteurs environnementaux et sociaux de la santé. » de l'ouvrage Psychologie de la santé : Concepts, méthodes et modèles, écrit par Marilou Bruchon-Schweitzer et Émilie Boujut et paru en 2021.

Il s'agit d'un texte à visée épistémologique qui traite des relations complexes entre la santé publique, la santé humaine et l'environnement. L'article fait remonter ces préoccupations au Vème siècle avant notre ère avec la médecine d'Hippocrate, mais les enjeux gestion de l'environnement apparaissent à la moitié du XXème siècle et sont encore une problématique actuelle.

Comment expliquer la place croissante de la relation entre santé et environnement dans les systèmes politique, social et médical ?

Selon les auteurs, la relation entre santé et environnement est au cœur de la pensée médicale depuis l'Antiquité Grecque bien que l'action sur l'environnement soit une préoccupation plus moderne. Agir sur l'environnement pour améliorer la santé est un projet complexe, de par la nature des maladies actuelles, et qui fait l'objet de nombreuses politiques nationales et internationales.

En premier lieu, la conception de la relation entre santé et environnement connaît plusieurs évolutions au cours de l'histoire qui participent à définir sa portée actuelle.

La relation entre santé et environnement apparaît en effet dès le Vème siècle avant notre ère dans le corpus hippocratique. Ce dernier met en avant la considération que la santé d'une personne dépend de l'espace dans lequel elle vit, ses contraintes et ses composantes : la pureté de l'air, la clarté de l'eau ou encore l'éclairement du soleil. Selon « la médecine d'Hippocrate » (l.1-2), ces conditions environnementales ont des conséquences sur la santé et sont responsables de différentes manifestations morbides chez la personne. Cependant, cette « influence de l'environnement » (l.1) ne possède pas tous les aspects que la médecine actuelle lui reconnait : le lien entre santé et environnement n'est pas systématique, il n'y a notamment pas de terme unique pour désigner l'environnement, et les éléments qui le composent sont plutôt considérés individuellement. De même, il n'existe pas de quantification de l'effet de ces facteurs environnementaux. De par son absence de préoccupation de santé publique, la médecine hippocratique n'a pas pour ambition l'action sur l'environnement dans ses activités de soin.

Il faut attendre le XIXème siècle et l'apparition du mouvement hygiéniste pour que l'action sur l'environnement intègre la pratique médicale. L'hygiénisme met l'accent sur les méthodes d'élimination et de contrôle des « maladies infectieuses » (l.2) en partant du principe qu'il faut agir sur l'environnement pour favoriser la santé et éradiquer certaines maladies. Ce projet ambitieux est notamment soutenu par des médecins tels John Snow, qui démontre au milieu

du XIXème siècle le mode de transmission du choléra. En effet, lors d'une épidémie de choléra à Londres, il constate que les cas de choléra des différents quartiers sont corrélés à la carte de desserte des différentes compagnies d'eau de la ville. Le démantèlement de la pompe à eau infectée participa grandement à mettre fin à l'épidémie. Les hygiénistes entreprennent alors de nombreux projets de reconfiguration urbaines et de mesures sanitaires : il faut « traiter l'eau » (l.3), « conserver les aliments au froid » (l.3), mais aussi « éliminer les ordures » (l.3-4), déplacer les cimetières...

Les origines de ces « maladies infectieuses » (l.2) sont identifiées durant le XIXème siècle avec la découverte des « agents pathogènes » (l.2-3) ; c'est la révolution bactériologique. Celle-ci désigne le moment d'élaboration de techniques de laboratoire permettant de visualiser les agents pathogènes responsables des maladies infectieuses. Bien que ces agents infectieux proviennent « du milieu » (l.3), l'action sur l'environnement passe au second plan au profit de la recherche médicale pour le traitement des maladies. Par exemple, Pasteur élabore le vaccin contre la rage à la fin du XIXème siècle.

Ce mouvement est couronné de succès : « les maladies infectieuses diminuèrent énormément » (l.4) avec une réduction notable de la mortalité, notamment dans les pays développés comme le Royaume-Uni ou le Japon. Cette réduction de la mortalité s'inscrit dans le phénomène de la transition épidémiologique, qui apparaît à la moitié du XXème siècle, et qui accompagne la transition démographique. Il est marqué d'une transformation des causes de décès depuis les maladies infectieuses vers les « maladies chroniques » (l.6). Parmi ces dernières figurent notamment les « maladies cardiovasculaires et les cancers » (l.5) qui sont liées au vieillissement de la population et plus complexes à soigner.

Toutefois, l'écart se creuse entre la prévalence de ces pathologies et les capacités de la médecine à les prendre en soin. Il manque en effet une pièce sur l'échiquier car « on a presque oublié [...] le rôle que l'environnement distal et proximal pouvait jouer sur la santé. » (l.7-8). Les dernières évolutions de la science ont fait considérer la santé comme dépendante uniquement du « style de vie » (l.6) de la personne, sa sédentarité, son alimentation, et aussi progressivement de ses caractéristiques génétiques. L'explication des épidémies par le seul germe infectieux se transmettant de personne à personne, issue de la révolution bactériologique, apparaît comme une approche réductionniste et monocausale, dite de la "contamination". Or, la « santé des populations » (l.8) requiert une approche plus complète au vu du nombre de paramètres qui rentrent en compte dans son étude. On passe alors à une approche dite de la "configuration", holistique et multicausale, où les causes de l'épidémie sont multiples et relèvent d'une perturbation de l'équilibre entre l'humain et son environnement.

La gestion de l'environnement initialement apparue avec les hygiénistes repasse donc au premier plan et se théorise avec l'apparition de plusieurs concepts clés.

La prévalence croissante des maladies chroniques illustrent en effet la difficile identification et prévention des facteurs de risque environnementaux.

La notion de « risques sanitaires liés à l'environnement » (l.11) est au centre des enjeux actuels de gestion de l'environnement. Elle se définit par la probabilité de survenue d'un événement de santé indésirable liée à l'exposition à un danger présent dans l'environnement. Ce danger revêt différentes natures (chimique, physique, radiative…) et est caractérisé par des critères de gravité (toxicité, létalité…). Il dépend des circonstances de contact avec le danger (durée et fréquence, dose reçue…). L'étude de ces risques sanitaires environnementaux se fait à partir de celle des « facteurs environnementaux » (l.8). On entend par facteurs environnementaux l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques et professionnels externes à une personne, ainsi que tous les comportements connexes, à l'exclusion des milieux naturels qui ne peuvent pas être raisonnablement modifiés. Tous ces phénomènes naturels et sociaux, influencés ou non par les activités humaines, vont avoir un retentissement sur la santé des individus.

La complexité des pathologies liées à l'environnement est corrélée à leur nature « plurifactorielle » (l.17). Cela signifie que la maladie est causée par une multiplicité d'agents envi-

ronnementaux nocifs, en interaction avec des facteurs génétiques. La dénomination d'étiologie complexe des maladies, qui s'oppose à l'étiologie simple où un unique agent environnemental cause une maladie aiguë (comme l'asbestose avec l'amiante), met donc en avant le fait que le « facteur déclenchant au niveau individuel » (l.18) est souvent impossible à identifier. C'est notamment le cas d'une exposition prolongée à faibles doses ; par exemple, les maladies respiratoires sont en partie dues aux particules fines.

Ces socles communs autour de la relation entre santé et environnement permettent donc la mise en place d'« instances collectives » (l.10) de gestions de risques, au « niveau local, national mais aussi international » (l.10). Une action universelle sur l'environnement est en effet nécessaire de par la dimension globale des enjeux qui la caractérise. Parmi ces instances internationales figure l'« ONU » (l.16) qui inscrit dans les lois internationales le « développement durable » (l.18), caractérisé par un développement réellement maîtrisé, capable de concilier les besoins humains et la préservation des équilibres écologiques, sociaux, économiques, y compris dans le long terme. En effet, les activités humaines de production, de logement, d'alimentation, de déplacement… sont responsables d'atteintes graves et répétées à l'environnement, causant une crise de l'anthropocène. Il est primordial de pouvoir assurer aux citoyens actuels et futurs du monde que ce dernier soit équitable, viable (stable dans la durée) et vivable. Plus tard, lors du sommet de New-York, 17 objectifs de développement durable sont mis en place, parmi lesquels « sept relèvent directement de considérations environnementales et sanitaires » (l.16-17) , illustrant l'intérêt croissant accordé aux relations et influences réciproques entre santé et environnement, activités humaines et ressources environnementales.

La complexité des enjeux de « santé environnementale » (l.20) implique la collaboration d'une multitude d'acteurs. Cela s'explique par la définition même de santé environnementale : une notion qui recouvre l'ensemble des facteurs liés à la qualité des milieux de vie des populations et pouvant avoir une influence sur la santé. Elle vise à réduire les menaces qui pèsent sur les individus dans leur ville, leur logement ou leur lieu de travail. La « prise de conscience » (l.19) doit donc s'opérer à plusieurs niveaux et la gestion des risques doit être partagée car tous les acteurs sont impliqués dans leur activités respectives : l'« opinion » (l.19) fait ici référence aux citoyens. Ceux-ci sont les premiers impactés par les effets de l'environnement et doit pouvoir faire entendre sa voix dans une optique démocratique de gestion des risques sanitaires environnementaux. Les « responsables politiques » (l.19) doivent concilier l'avis des différents acteurs en prenant en compte les débats internationaux pour promouvoir des réglementations concrètes, réalistes et utiles. Les « industriels » (l.19) doivent faire évoluer leurs modes de production pour en exploiter de nouveaux, plus respectueux de l'environnement et, subséquemment, de la santé des populations. Les « scientifiques » (l.20) et les « spécialistes de la santé et de l'environnement » (l.21) doivent réfléchir aux solutions efficaces pour prévenir les agressions à la Terre et limiter les conséquences de leur aggravation sur la santé de l'homme. Tous ces acteurs « travaillent ensemble » (l.21) pour décider de la gestion des risques sanitaires environnementaux.

En conclusion, les risques sanitaires environnementaux sont une préoccupation moderne liée à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques complexes et aux conséquences de la dégradation croissante de l'environnement. Agir sur l'environnement implique une concertation de tous les acteurs pour aboutir à des décisions justes et équitables sous le sceptre du respect des limites planétaires.

Cependant, la relation entre santé et environnement ne doit pas être considérée uniquement sous ses aspects négatifs, de “risque” et de “maladie”. Il est primordial de considérer les bienfaits que peut avoir l'environnement sur la santé humaine ; par exemple, la présence d'arbre en milieu urbain pourrait présenter de nombreux bienfaits pour la santé humaine, avec la réduction des maladies cardio-vasculaires et le maintien du lien social. Il s'agit d'une piste prometteuse pour lutter contre les maladies chroniques et favoriser la résilience des espaces urbains face au dérèglement climatique.

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM EB SHS 2025-2026)

Relecteurs :
Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM EB SHS 2025-2026), Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM GT SHS 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Souad BENABDI (DFGSM2) et Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team SHesS**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM SHS GT 25-26) et Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM SHS EB 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP